

Guía de Oportunidades para Toda la Vida 81 — Tecnólogo en información de salud y registrador médico

Versión: 2.0, maestro de trabajo controlado

Idioma: español neutro de América Latina (es-419)

Fuente inglesa congelada: blob

321a7cac380aa12ea340325e5b1a150eb0a93f1b

Referencia principal de EE. UU.: O*NET-SOC 29-9021.00 — Health Information Technologists and Medical Registrars

Comparación de Canadá: NOC 12111 — Health information management occupations

Comparación de Colombia: CUOC 32520 — Técnicos en documentación sanitaria

Fecha de revisión: 2026-08-21

Qué es esta carrera

Quienes trabajan en tecnología de información de salud y registros médicos convierten información clínica y administrativa en registros, clasificaciones, registros especializados, reportes y sistemas de información precisos, seguros y utilizables. Según el cargo, pueden abstraer información de historias clínicas, clasificar o codificar datos, apoyar sistemas de historia clínica electrónica, mantener registros de enfermedades o tratamientos, revisar calidad de datos, preparar informes, recuperar registros, apoyar procedimientos de privacidad/ciberseguridad, capacitar personal y mejorar flujos de información sanitaria.

El trabajo está entre salud, gestión de información y tecnología. Requiere suficiente conocimiento de terminología médica y procesos de atención para entender la documentación, suficiente disciplina de información para conservar registros confiables y suficiente juicio técnico para reconocer cuándo un asunto de codificación, privacidad, clínica o sistemas debe escalar.

Esta guía usa **O*NET-SOC 29-9021.00 — Health Information Technologists and Medical Registrars** como referencia principal de Estados Unidos. Canadá tiene una correspondencia estrecha con **NOC 12111 — Health information management occupations**. Colombia cuenta con una correspondencia directa en **CUOC 32520 — Técnicos en documentación sanitaria**.

Por qué puede ser una buena oportunidad

La ocupación de Estados Unidos está clasificada actualmente como Bright Outlook. Las organizaciones de salud siguen digitalizando registros, mejorando la calidad de los datos, ampliando registros especializados y analítica, aumentando interoperabilidad, gestionando requisitos de privacidad/ciberseguridad e incorporando automatización. Todo esto aumenta la necesidad de personas que comprendan tanto información sanitaria como sistemas.

La ruta puede comenzar desde administración de salud, registros médicos, codificación, facturación, admisiones, apoyo clínico, entrada de datos, calidad, salud pública, seguros, gestión documental, TI o atención a pacientes.

Una progresión realista puede ser:

apoyo administrativo o de registros en salud → técnico/tecnólogo o registrador de información de salud → especialización en codificación, registros o calidad de datos → analista, especialista de sistemas, documentación clínica, informática de salud, supervisión o gestión.

El camino exacto depende de educación, jurisdicción, empleador, especialidad y credenciales.

Tecnólogo en información de salud, registrador médico, codificador, especialista de registros e informático de salud no son el mismo rol

Tecnólogo en información de salud

Puede trabajar con:

- historia clínica electrónica (EHR/HCE);
- calidad y validación de datos;
- informes;
- bases de datos y extracciones;
- implantación o actualización de sistemas;
- análisis de flujos de trabajo;
- controles de privacidad/ciberseguridad;
- capacitación de usuarios;
- índices y sistemas de almacenamiento/recuperación.

Registrador médico

En este contexto, “registrador” puede referirse a registros de enfermedades, tumores/cáncer u otros registros clínicos especializados; no se refiere a un título de formación médica como profesional tratante.

Puede:

- abstraer información clínica definida;
- clasificar casos según reglas del registro;
- hacer seguimiento;
- mantener integridad y calidad del registro;
- preparar estadísticas e informes;
- apoyar investigación, vigilancia o mejora de calidad.

Algunos registros especializados exigen formación o credenciales específicas.

Codificador médico

Aplica sistemas de clasificación y reglas aprobadas a información clínica documentada. **Codificar no es diagnosticar.** No se debe inventar un diagnóstico porque parezca clínicamente probable.

Especialista de registros médicos

Puede concentrarse más en integridad del expediente, liberación de información, escaneo/indexación, colas documentales, flujos de corrección, recuperación de registros, identidad del paciente y controles administrativos.

Especialista en informática de salud

Puede tener responsabilidad más amplia sobre sistemas clínicos, diseño de flujos, estándares, analítica, interoperabilidad, implementación y estrategia tecnológica. Algunos cargos requieren formación o experiencia técnica más avanzada.

Autoridad y límites clínicos/profesionales

Un título de información de salud **no** autoriza automáticamente a una persona para:

- diagnosticar una enfermedad;
- prescribir o recomendar tratamiento;
- interpretar de forma independiente un hallazgo clínico para atención del paciente;
- inventar o inferir un diagnóstico para completar una reclamación o un registro;

- cambiar documentación fuente del profesional clínico fuera de un flujo aprobado de corrección/enmienda;
- asignar un código que no esté sustentado por la documentación y las reglas aplicables;
- eliminar información clínicamente relevante porque resulte incómoda;
- divulgar información sanitaria protegida solo porque técnicamente puede acceder a ella;
- determinar por cuenta propia cumplimiento legal/regulatorio salvo que esa función esté formalmente asignada;
- decidir calendarios de retención/destrucción o retirar un legal hold sin autoridad;
- diseñar arquitectura de ciberseguridad de producción sin responsabilidad asignada;
- usar información sanitaria real protegida en un portafolio público o sistema de IA no aprobado;
- afirmar una certificación, licencia, registro o acreditación que no posea.

Cuando la documentación sea incompleta, contradictoria o ambigua, use el proceso aprobado de consulta al profesional clínico, equipo de codificación o registro. O*NET reconoce expresamente la consulta a médicos u otras personas cuando existen códigos o diagnósticos conflictivos, faltantes o poco claros.

Ciclo de vida de la información de salud

1. Capturar la información fuente

La información puede venir de:

- notas clínicas;
- resultados diagnósticos;
- laboratorio e imágenes;
- órdenes;
- notas quirúrgicas/procedimientos;
- medicamentos;
- ingreso/alta;
- datos demográficos;
- facturación/reclamaciones;
- dispositivos e interfaces;
- salud pública;
- información reportada por pacientes;
- registros externos.

Debe conocerse cuál fuente es autorizada para la tarea y si está completa.

2. Confirmar identidad del paciente y del registro

Los errores de identificación pueden generar riesgos clínicos y de privacidad. Siga procedimientos aprobados y revise nombre, alias, fecha de nacimiento, número de historia clínica, número de encuentro/cuenta, dirección, duplicados, fusiones, instalación y fechas de servicio.

No fusione ni modifique identidades fuera de la autoridad asignada.

3. Abstractar y clasificar

Abstractar significa extraer información definida de la historia clínica según un diccionario de datos, regla de registro, regla de codificación o requisito de reporte.

Requiere definiciones consistentes, trazabilidad de fuente, contexto correcto de fecha/hora, distinguir hecho documentado de interpretación, manejar faltantes correctamente y escalar ambigüedades.

4. Validar calidad de datos

La calidad puede incluir:

- integridad;
- exactitud;
- consistencia;
- oportunidad;
- validez;
- unicidad;
- identidad correcta del paciente;
- codificación/clasificación correcta;
- trazabilidad a fuente;
- estado correcto de acceso/seguridad.

Un campo lleno no necesariamente es un campo correcto.

5. Almacenar y proteger

Siga reglas aprobadas para almacenamiento en HCE/base de datos, indexación, estado del registro, historial de versión/enmienda, permisos, retención, copias/recuperación, legal hold, auditoría y liberación de información.

6. Recuperar y liberar información

Antes de entregar información verifique identidad del solicitante, autoridad/autorización, flujo de liberación, paciente correcto, rango de fechas/tipo documental, alcance mínimo necesario cuando aplique, redacción, canal seguro y requisitos de registro.

7. Analizar y reportar

Puede preparar:

- censos/utilización;
- reportes de registros;
- métricas de calidad;
- tendencias de codificación/documentación;
- reportes de integridad;
- tableros operativos;
- estadísticas de enfermedades/tratamientos;
- excepciones de calidad.

Diferencie presentar datos de emitir una conclusión clínica.

Codificación clínica e integridad documental

La codificación puede utilizar sistemas de diagnóstico/procedimiento, DRG y herramientas encoder. Los sistemas y reglas varían por país, pagador, especialidad y entorno.

Reglas clave:

- codifique desde documentación autorizada;
- use la norma/versión requerida;
- no cree diagnósticos faltantes;
- conserve trazabilidad;
- consulte información poco clara o contradictoria;
- diferencie validación clínica de validación de codificación;
- no cambie documentación para obtener un resultado de reembolso preferido;
- escale presión inapropiada o sospecha de fraude por canales autorizados.

Trabajo de registros clínicos especializados

Los registros pueden seguir cáncer/tumores, trauma, implantes, enfermedades, procedimientos, resultados u otras poblaciones.

Comprenda criterios de inclusión/exclusión, búsqueda de casos, reglas de abstracción, seguimiento, clasificación/estadificación, fuentes obligatorias, ediciones de calidad, prevención de duplicados, fechas límite, confidencialidad y gobernanza del registro.

No aplique una clasificación clínica fuera de las reglas y formación exigidas por ese registro.

Sistemas de información de salud

Conceptos útiles:

- EHR/HCE;
- índice maestro de pacientes;
- documentación clínica;
- interfaces de laboratorio/radiología;
- herramientas de codificación;
- liberación de información;
- gestión de imágenes/documentos;
- software de registros;
- bases de datos/consultas;
- business intelligence/reporting;
- interoperabilidad;
- identidad/acceso;
- auditoría;
- procedimientos de contingencia y recuperación.

El tecnólogo puede apoyar pruebas, implementación, capacitación y mejora. Esto no lo convierte automáticamente en DBA, ingeniero de software o arquitecto de seguridad.

Calidad de datos: método repetible

1. identifique el elemento y fuente autorizada;
2. verifique paciente/encuentro;
3. aplique definición/regla vigente;
4. capture o valide el valor;
5. ejecute ediciones requeridas;
6. revise faltantes/conflictos;
7. consulte o escale;
8. documente resolución;
9. confirme impacto aguas abajo;
10. conserve evidencia de auditoría.

No “limpie” datos clínicos eliminando valores inusuales pero legítimos.

Privacidad y confidencialidad

Buenas prácticas:

- acceder solo a registros necesarios para el trabajo asignado;
- nunca usar la cuenta de otra persona;
- proteger contraseñas y MFA;
- bloquear estación al ausentarse;

- verificar destinatario;
- evitar conversaciones sobre pacientes en áreas públicas;
- usar almacenamiento/transmisión aprobados;
- reportar información mal dirigida;
- seguir reglas de impresión/destrucción/papel;
- evitar descargas/exportaciones innecesarias;
- no curiosear historias clínicas.

La legislación de privacidad varía. Siga la ley aplicable y la política del empleador; esta guía no es asesoría legal.

Ciberseguridad en información de salud

Los sistemas de salud son objetivos frecuentes de phishing, robo de credenciales, ransomware y exfiltración.

Prácticas:

- reconocer mensajes sospechosos;
- usar MFA;
- reportar prompts MFA inesperados;
- verificar solicitudes inusuales de grandes exportaciones;
- usar dispositivos/redes aprobados;
- no desactivar controles de seguridad;
- evitar USB/nube personal no autorizados;
- seguir procedimientos de contingencia;
- reportar acceso no autorizado.

Que una exportación sea técnicamente posible no significa que esté autorizada.

Uso responsable de IA y automatización

Los flujos pueden usar OCR, codificación asistida por computador, NLP, motores de reglas, detección de duplicados, modelos predictivos e IA generativa.

La automatización aprobada puede ayudar a extraer campos candidatos, detectar documentación faltante, sugerir clasificaciones, encontrar duplicados, generar datos sintéticos o apoyar entrenamiento.

Para información real:

- use solo sistemas y clases de datos aprobados;
- conserve trazabilidad de fuente;
- verifique extracción/codificación/resumen;
- nunca permita que la IA invente diagnóstico o hecho clínico;

- mantenga aprobación humana cuando se exija;
- monitoree errores sistemáticos y sesgo;
- proteja información sanitaria;
- preserve auditoría;
- escale resultados inseguros o inexplicables.

NIST AI RMF es orientación voluntaria para gestión de riesgos y el perfil de IA generativa aborda riesgos específicos. No sustituyen gobernanza clínica, de codificación, privacidad, seguridad o legal.

Accesibilidad e inclusión

Los sistemas y documentos deberían apoyar a usuarios con discapacidad cuando corresponda. Principios: navegación por teclado, etiquetas significativas, contraste legible, foco visible, mensajes de error útiles, orden lógico, documentos electrónicos accesibles, compatibilidad con tecnologías de asistencia, subtítulos/transcripciones y evitar significado solo por color.

Una herramienta automática no demuestra cumplimiento legal completo de accesibilidad.

Ruta en Estados Unidos

Preparación

O*NET ubica la ocupación en **Job Zone Three — Medium Preparation Needed**. Son comunes formación vocacional, experiencia relacionada o grado asociado; suele requerirse uno a dos años de formación con experiencia en el trabajo.

Antecedentes útiles: tecnología de información de salud, registros médicos, codificación, administración sanitaria, registros clínicos, datos/analítica, apoyo clínico o TI en salud.

Registered Apprenticeship

O*NET muestra títulos aprobados de ejemplo:

- Clinical Documentation Improvement Specialist;
- Health Information Technologist (Nof);
- Tumor Registrar.

Un título aprobado no significa que exista una vacante de aprendizaje disponible hoy en cada zona.

WIOA

CareerOneStop ayuda a localizar capacitación elegible para WIOA. Confirme elegibilidad personal y reconocimiento de credenciales antes de matricularse.

Salarios y proyección de Estados Unidos

Datos nacionales O*NET/BLS 2025 para **29-9021.00**:

Percentil	Anual	Por hora
10	\$39,830	\$19.15
25	\$48,940	\$23.53
Mediana	\$68,020	\$32.70
75	\$95,630	\$45.98
90	\$117,420	\$56.45

Proyección 2024-2034:

- empleo 2024: **41,900**;
- empleo proyectado 2034: **48,100**;
- crecimiento: **15%**;
- vacantes proyectadas **anuales: 3,200**.

Contexto no gubernamental de un título relacionado

Indeed reportó aproximadamente **\$21.15/hora** para **Health Information Technician**, con **701 salarios**, actualizado el **31 de julio de 2026**.

Es una estimación de un título relacionado que puede representar funciones más junior o estrechas. No sustituye la serie oficial de O*NET/BLS.

Señales actuales de software en EE. UU.

O*NET 2025 muestra:

- Microsoft Office **12%**;
- Excel **8%**;
- Epic Systems **4%**;
- Outlook **4%**;
- Word **2%**;
- PowerPoint **2%**;
- MEDITECH **1%**;
- Access **1%**.

También aparecen familias de EHR, codificación, bases/SQL, gestión documental, OCR y analítica. Aprenda conceptos transferibles.

Ruta en Canadá

Job Bank identifica **NOC 12111 — Health information management occupations**.

Los requisitos actuales indican un **diploma universitario/colegial reconocido de dos años** en tecnología de registros de salud o gestión de información de salud.

Las personas son elegibles para presentar el examen nacional de certificación de la **Canadian Health Information Management Association**, que **puede ser exigido por empleadores**.

Los registros actuales de Job Bank indican que la ocupación **no está regulada en Canadá**. Esto no impide que empleadores exijan certificación.

Salarios nacionales actualizados el 19 de noviembre de 2025:

- bajo **C\$22.00/hora**;
- mediana **C\$30.51/hora**;
- alto **C\$46.19/hora**.

Canada.ca ayuda a localizar formación reconocida, apoyo estudiantil y recursos de capacitación. Verifique si un programa cumple expectativas de empleadores/certificación.

Ruta en Colombia

CUOC 32520 — Técnicos en documentación sanitaria

Es una correspondencia ocupacional directa. Denominaciones relevantes:

- Administrador de información de salud;
- Administrador de registros de salud;
- Analista de registros médicos;
- Auxiliar de codificación clínica;
- Auxiliar de información de salud;
- Auxiliar de registros médicos;
- Supervisor de auxiliares de registros en salud;
- Supervisor de unidad de registros médicos;
- Técnico de información de salud;
- Técnico de información sanitaria;
- Técnico de registro de enfermedades;
- Técnico de registros médicos.

Las funciones incluyen índices y almacenamiento/recuperación de historias, procesamiento de registros/admisiones, información para vigilancia,

investigación, facturación/costos/mejora y revisión de integridad, exactitud y cumplimiento.

OCUPACOL no proporciona aquí una serie salarial estadísticamente representativa adecuada para una afirmación nacional controlada. No invente una.

SENA — Apoyo administrativo en salud

SENA Betowa lista **Apoyo administrativo en salud** como programa **Técnico de 2,640 horas**.

Competencias relevantes: admitir personas según normativa, procesar afiliaciones, registrar información según normativa/procedimiento técnico y utilizar herramientas informáticas.

Es una base útil, no equivalencia automática con todas las credenciales de HIM, codificación o registros. Los cupos, lugares y cohortes cambian.

América Latina y el Caribe

El observatorio de OIT/Cinterfor ayuda a identificar instituciones nacionales de formación profesional. Verifique directamente programa, credencial, admisión, reconocimiento, modalidad y costo.

Portafolio sintético: nunca use datos reales de pacientes

Puede demostrar habilidades con datos totalmente sintéticos o públicos no identificables.

Ejemplos:

1. auditoría sintética de integridad de historias;
2. diccionario de datos de un registro ficticio;
3. ejercicio de detección de duplicados sintéticos;
4. flujo de consulta de documentación/codificación;
5. tablero de calidad con datos ficticios;
6. checklist de liberación de información;
7. mapa de flujo EHR;
8. matriz de control de acceso;
9. cola ficticia de seguimiento de registro;
10. árbol de decisión de incidente de privacidad/ciberseguridad.

No use nombres reales, números reales de historia clínica, fechas reales vinculadas a personas, capturas de producción o datos protegidos de empleadores/clientes sin autorización explícita y legal.

Evidencia para el currículum

Puede demostrar mejoras de integridad, calidad de codificación/registro, validación, identidad del paciente, reducción de backlog, soporte EHR, reportes/tableros, capacitación, liberación de información, privacidad/ciberseguridad, auditoría, pruebas de sistemas o resolución de consultas.

Use solo métricas reales que pueda respaldar.

Preparación para entrevista

Prepárese para responder:

- ¿Qué hace si la documentación no sustenta el código solicitado?
- ¿Cómo resuelve documentación clínica contradictoria?
- ¿Cómo protege información sanitaria sensible?
- ¿Qué hace que un dato de salud sea de calidad?
- ¿Cómo validaría una abstracción de registro?
- ¿Cómo previene duplicados de pacientes?
- ¿Qué experiencia tiene con EHR?
- ¿Qué haría ante una solicitud inusual de exportación masiva?
- ¿Cómo validaría codificación o extracción asistida por IA?
- ¿Cómo diferencia codificación de diagnóstico clínico?

Una buena respuesta enfatiza fuente, reglas, verificación y escalamiento.

Preguntas para el empleador

Pregunte por EHR/registro/codificación usados, credenciales obligatorias/preferidas, estándares, consultas clínicas, métricas de calidad, dueño de privacidad/liberación, controles de acceso, contingencia/ciberincidentes, IA/codificación asistida aprobada, revisión humana, capacitación y rutas de avance.

Primeros 30 días

Días 1-5

- aprender políticas de registros y privacidad;
- comprender identidad del paciente;
- aprender EHR/registro/codificación;
- identificar documentación fuente;
- aprender consultas/escalamiento;
- comprender acceso/liberación.

Días 6-15

- realizar abstracciones o revisiones supervisadas;

- aprender ediciones de calidad;
- practicar recuperación/liberación;
- revisar controles de duplicados;
- aprender auditoría/historial;
- estudiar estándares aplicables.

Días 16-30

- mejorar precisión y tiempos;
- identificar problemas repetitivos;
- aprender una herramienta de reporte/consulta;
- participar en revisión supervisada;
- solicitar retroalimentación con métricas reales.

Plan de 90 días

Mes 1: registros, privacidad, terminología, identidad y EHR.

Mes 2: clasificación, registros, abstracción, consultas y calidad.

Mes 3: SQL/consultas, reporting, pruebas, flujos, interoperabilidad, gobernanza de IA y seguridad.

Lista práctica de información de salud

Antes:

- ☐ Paciente/encuentro correcto.
- ☐ Fuente autorizada confirmada.
- ☐ Documentación requerida presente.
- ☐ Norma/versión/cola correcta.

Durante:

- ☐ Sin inferencia clínica no sustentada.
- ☐ Reglas de codificación/abstracción aplicadas.
- ☐ Faltantes/conflictos consultados o escalados.
- ☐ Trazabilidad conservada.
- ☐ Confidencialidad mantenida.

Antes de completar:

- ☐ Ediciones requeridas revisadas.
- ☐ Estado del registro correcto.
- ☐ Evidencia de consulta/auditoría registrada.
- ☐ Enrutamiento de reporte/liberación completado.

Lista práctica de privacidad/liberación

- ☐ Identidad del solicitante verificada.

- ☐ Autorización/autoridad confirmada.
- ☐ Paciente/rango de fechas correctos.
- ☐ Alcance mínimo/aprobado aplicado.
- ☐ Redacción revisada cuando corresponda.
- ☐ Canal seguro usado.
- ☐ Liberación documentada.
- ☐ Sin copia no autorizada retenida.

Lista práctica de IA/automatización

- ☐ Herramienta aprobada para la clase de datos.
- ☐ Información protegida manejada según autorización.
- ☐ Trazabilidad de fuente conservada.
- ☐ Salida de IA/OCR/codificación verificada.
- ☐ No se inventaron hechos clínicos.
- ☐ Aprobación humana requerida completa.
- ☐ Errores/excepciones sistemáticos revisados.
- ☐ Evidencia de auditoría conservada.

Fuentes para verificar antes de decisiones importantes

- O*NET detalles: <https://www.onetonline.org/link/details/29-9021.00>
- O*NET resumen: <https://www.onetonline.org/link/summary/29-9021.00>
- O*NET Job Zone: <https://www.onetonline.org/skills/zone/29-9021.00>
- O*NET/BLS salarios: <https://www.onetonline.org/link/localwages/29-9021.00>
- O*NET/BLS tendencias: <https://www.onetonline.org/link/localtrends/29-9021.00>
- O*NET software demandado: <https://www.onetonline.org/link/demand/29-9021.00>
- O*NET hot technologies: https://www.onetonline.org/link/hot_tech/29-9021.00
- CareerOneStop WIOA: <https://www.careeronestop.org/LocalHelp/EmploymentAndTraining/find-WIOA-training-programs.aspx>
- Indeed Health Information Technician: <https://www.indeed.com/career/health-information-technician/salaries>
- Canada Job Bank resumen: <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/summary-occupation/25618/ca>
- Canada Job Bank requisitos: <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/requirements/25618/ca>
- Canada Job Bank salarios: <https://www.jobbank.gc.ca/wagereport/occupation/25618>

- Canada capacitación: <https://www.canada.ca/en/services/jobs/training.html>
- OCUPACOL CUOC 32520: <https://ocupacol.mintrabajo.gov.co/Profile/OccupationalProfile/32520>
- SENA Apoyo administrativo en salud: <https://betowa.sena.edu.co/oferta/apoyo-administrativo-en-salud?location=57011001&modality=P&offertype=open&programId=212936>
- OIT/Cinterfor: <https://www.oitcinterfor.org/statsfp/paises>
- CISA Secure Our World: <https://www.cisa.gov/secure-our-world>
- NIST AI RMF: <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>
- NIST perfil de IA generativa: <https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence>
- Section508.gov: <https://www.section508.gov/create/>

Límite de aseguramiento

Esta guía ofrece información educativa y de planificación profesional general. No es asesoría médica, de codificación, legal, de privacidad, ciberseguridad, retención de registros, financiera, laboral, migratoria ni regulatoria. No certifica competencia clínica, exactitud de codificación, registro profesional, licencia, cumplimiento de privacidad, accesibilidad, ciberseguridad ni calidad de traducción.

Los requisitos cambian según empleador, jurisdicción, especialidad y organismo de credenciales. No se garantiza empleo, ingreso, admisión, financiación, certificación, licencia ni promoción.

Autor, asistencia de IA y licencia

Creada y dirigida por **Alberto “Al” Leiva**. ChatGPT apoyó investigación actual, organización, edición, apoyo de traducción y preparación documental bajo dirección del autor. El autor mantiene responsabilidad por decisiones editoriales y de publicación.

Salvo indicación distinta, este material se licencia bajo **CC BY-NC-SA 4.0**.